

Gota · crise aguda e prevenção

Crise de gota = artrite inflamatória aguda, classicamente 1ª MTP. Trate a inflamação na crise; deixe o hipouricemiante para a estratégia de longo prazo, com profilaxia ao iniciar.

Diagnóstico

Dica - Diagnóstico

Padrão-ouro: cristais de urato (-) birefringentes no líquido sinovial. Ácido úrico pode estar normal na crise — não exclui gota.

Não misture fases: primeiro apague o fogo articular; depois baixe o urato com plano.

Manejo da gota

Crise -> resolução -> prevenção

Crise

AINE / colchicina / CE

Confirmar

cristal / acido urico

Prevenir

alopurinol + profilaxia

Conduta

- Crise: AINE, colchicina precoce ou corticoide (via oral/intra-articular) conforme comorbidades
- Evitar iniciar/ajustar alopurinol no auge da crise sem cobertura anti-inflamatória
- Alvo de uricemia tipicamente <6 mg/dL (<5 se tofos/doença grave)
- Ajustar alopurinol na IRC; atenção a interação com azatioprina

Gota × pseudogota

Item | Gota (urato) | Pseudogota (CPP)

Articulação típica | 1ª MTP / pé | Joelho / punho

Cristal | Agulha, birefringência (") | Romboide, birefringência (+)

Radiografia | Tofos / erosões | Condrocalcinose

Contexto | Hiperuricemia, diurético | Idoso, metabólico

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Monoartrite aguda é artrite séptica até prova em contrário se houver febre/risco — puncione. Não 'trate gota no escuro' sem considerar infecção.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Crítérios clínicos e urato sérico sustentam a crise de gota e a decisão entre anti-inflamatório e hipouricemiante.

Padrão-ouro: cristais de urato monossódico no líquido (birrefringência negativa).

Diagnostico de gota (ideia)

Clinico + lab + cristal

- 1 Monoartrite aguda (1ª MTP = podagra)
- 2 Início rápido, dor intensa, eritema
- 3 Hiperuricemia (suporte, não obrigatória na crise)
- 4 Cristais UMS no líquido sinovial
- 5 Resposta rápida a colchicina/AINE/corticoide

Urato pode estar normal na crise aguda

Na crise: anti-inflamatório. Hipouricemiante depois, com profilaxia de flare.

Agudo vs crônico



Gota vs pseudogota

| Gota (UMS) | Pseudogota (CPPD)

Cristal | agulhas; birrefringência (-) | romboides; birrefringência (+)

Articulação típica | 1ª MTP, podagra | joelho

Rx | punched-out / tofos | condrocalcinose

Tratamento

- Crise: AINE ou colchicina precoce ou corticoide (articular/sistêmico)
- Meta urato crônico: geralmente < 6 mg/dL (< 5 se tofos)
- Alopurinol: 1ª linha; ajustar na DRC; HLA-B*5801 em riscos
- Profilaxia de flare ao iniciar hipouricemiante (colchicina baixa dose)

Precipitantes

Dica - Precipitantes

Álcool, frutos do mar/carnes purínicas, diuréticos, desidratação, cirurgia, internação.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1